

Fecha Última Actualización: 06-04-2023 14:25:58

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Constanza Alejandra Godoy Tirado **Rut** : 18.833.707-4 **N° Archivo** : 1134522
Edad : 28a 5m 19d **Fecha Nacto**: 18/10/1994 **Sexo** : Femenino
Dirección : C/Sargento Menadier 2635 D/316, V. San **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 3968 1410

N° Epicrisis
348448

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Ingreso** : 07/02/2023 12:54 **Días Estadía**: 58
Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Egreso** : 06/04/2023 14:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

DISFAGIA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

AM: Hipotiroidismo, Trastorno de personalidad
AQ: Gastrectomía parcial del fondo por ingesta de ácido muriático en contexto de intento de autólisis (08/01/23)
Alergias: AAS
Farmacós: Levotiroxina 100 mcg/día, Quetiapina 25 mg/día noche

Paciente con historia de hospitalización reciente por intento de autólisis por ingesta de soda cáustica. EDA con diagnóstico de esofagitis cáustica severa Zargar IIIb+ bulboduodenitis cáustica severa + gastritis cáustica severa universal y úlceras en segunda porción de duodeno. TC TAP muestra engrosamiento mural difuso del esófago torácico, con mínimo aumento densidad tejido adiposo periesofágico + engrosamiento mural difuso del estómago con aumento densidad tejido adiposo perigástrico principalmente en curvatura menor y en curvatura mayor a nivel del fondo gástrico, este último nivel existe un área de menor definición mural sospechoso de perforación con una colección perigástrica aparentemente contenida de 2,5 x 1,1 cm. El duodeno muestra engrosamiento mural difuso. sin líquido libre ni neumoperitoneo. Se decide laparotomía exploradora, en la cual se encuentra área de necrosis en fondo de estómago, con perforación hacia bazo, realizándose gastrectomía parcial del fondo gástrico, cirugía sin incidentes. Evolución sin incidentes, siendo dada de alta el 26/01/23.

EDA de control: Estenosis esofágica distal de origen cáustico, estómago y duodeno no evaluados.

Se decide hospitalización para realizar EDA + dilatación, previa preparación. Se inicia NPTC y se agenda procedimiento para el 15/02/23. Evoluciona con broncoespasmo severo durante inducción, por lo que se suspende procedimiento. Se decide postergar extubación y hospitalizar en UCI. Evoluciona estable, RxTx control con pulmones expandidos bilateral. Se inicia suspensión de sedación a las 24 hrs desde su ingreso, logrando extubarse el viernes 17/02. Se traslada a sala.

El día 01/03 EDA evidencia estenosis 3mm a 39cm AD. Se realiza dilatación, se evidencia píloro puntiforme, guía no logra avanzar más de 25mm. Se decide programar cirugía abierta.

El día 06/03/23 se realiza Gastrectomía total abierta, GY anastomosis. Evoluciona en el post-operatorio con infección intra-abdominal. Recibió 10 días de tratamiento antibiótico con imipenem + vancomicina ajustado a microbiología KPN BLEE y SAMR S anginosus obtenidos el 16/03 por punción de colección. TAC control 29/03 sin evidencia de colecciones, burbujas de gas sub-diafragmáticas e inflamación área lecho quirúrgico. Posteriormente se informa de aparición de rash, asociado a la administración de antibióticos.

Fecha Epicrisis : 06/04/2023 14:25

Página 1 de 2

Se realiza Hemocultivos por cuadro de peak febril el día 30/3/2023: negativos. Urocultivo negativo. Se suspende vancomicina, evoluciona posteriormente con resolución de rash cutáneo, disminución progresiva de parámetros inflamatorios. Completa 5 días afebril, sin taquicardia, sin dolor abdominal. Se suspende imipenem. Se conversa con equipo de infectología, se decide alta y seguimiento ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

EFFECTO TOXICO DE ALCALIS CAUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

En BCG, afebril.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Regimen papilla a tolerancia hiperproteico

Paracetamol 1g cada 8hr por 7 días via oral molido

Metamizol 300mg 1 comp S.O.S si dolor

Clorfenamina 4mg 1 comp cada 12h por 7 días via oral molido

Quetiapina 100mg cada noche via oral molido

Levotiroxina 100mcg cada mañana via oral molido

Control con Dr. Martin Inzunza en 2 semanas en CDT Pasillo 11, acudir con esta epicrisis, agendar hora. SOBRECUPO AUTORIZADO.

Se deja interconsulta para psiquiatría ambulatoria, será contactada.

Endoscopia digestiva alta solicitada, será contactada.

Acudir al S urgencias en caso de dolor intenso, vomitos, fiebre, o en caso de estimar necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Papilla

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Pamela Contreras Campbell

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)